

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	先天性梅毒 Congenital Syphilis				
編號	A31000-Q03-W-N02	制定者	IR 劉淑娟	公布日期	97 年 05 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	111 年 09 月 06 日
版本/總頁數	第 3.5 版/6 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	113 年 08 月 08 日

一、目的

讓護理人員了解先天性梅毒的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

先天性梅毒是指梅毒螺旋體(*Treponema pallidum*)由母體經胎盤進入胎兒血循環所致的感染，其中兩歲以內發病者為早期梅毒，主要是感染和炎症的直接結果。兩歲後為晚期梅毒，主要為早期感染一裂的畸形或慢性損害。

（二）症狀

早發型先天性梅毒的臨床表現最常見的包括肝脾腫大、皮疹、骨骼病變。其他還有黃疸、肝炎、貧血、血小板低下、淋巴腺病變、非免疫性胎兒水腫、胎內生長遲緩、胰臟炎、肺炎等等。

遲發型先天性梅毒最典型為 Hutchinson 牙齒、間質性角膜炎(interstitial keratitis)和神經性耳聾三項，稱之為 Hutchinson's triad。其他還可能出現桑椹白齒(mulberry molars)、鞍裂(rhagades)、智障、水腦、癲癇、腦神經麻痺、前額凸出、馬鞍鼻(saddle-nose)突起的下頷、軍刀狀小腿(saber shin)等。

（三）常見檢查

1. 非梅毒螺旋體抗原試驗 VDRL(Veneral Disease Research Laboratory)。

主題名稱	先天性梅毒	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N02	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	2/6

2. 梅毒螺旋體抗原試驗 TPHA(Treponemal Pallidum Hemoagglutinin Test)。
3. 顯微鏡暗視野檢查。
4. 全血球計數(CBC/DC)及分類：可見到單核球增多的現象。
5. 腰椎穿刺。
6. 放射學檢查。

(四) 常見治療

1. 治療-懷孕母親

- (1) 早期感染(<1ys)：Benzathine penicillin 240,000U IM 1-2 週。
- (2) 晚期感染(>1ys)：Benzathine penicillin 240,000U IM 3 週。

2. 追蹤-懷孕母親

- (1) 在懷孕期間有接受治療者，應每月做一次 VDRL/RPR test。
- (2) 若有抗體效價四倍以上者應重新接受治療。
- (3) 若治療後 1-3 個月抗體效價仍未下降，應重新接受治療。

3. 嬰兒應接受治療

- (1) 有臨床症狀或 X 光檢查異常。
- (2) VDRL/RPR 的抗體效價比媽媽高四倍以上。
- (3) CSF VDDL 陽性，或 CSF cell count protein 異常。
- (4) FTA-ABS IgM 陽性。
- (5) 檢驗結果不能排除感染的可能性。
- (6) 沒有接受全部的檢驗。
- (7) 感染梅毒母親在懷孕時未曾接受適當治療。

4. 病嬰治療及追蹤

- (1) Aqueous penicillin G 5 萬 U/Kg/dose IV ×10-14day。
- (2) 母親有接受完整治療而嬰兒檢查皆正常者，可只做追蹤或接受單劑
benzathine penicillin G IM 5 萬/Kg。
- (3) 疑似感染者無需隔離，只需要 standard precaution，但在開始治療 24 小時

主題名稱	先天性梅毒	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N02	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	3/6

內，必須戴手套接觸小孩。

(4) 在 3、6、12 個月時應再做 VDRL/RPR test 評估。

(五) 護理問題

易感染／因致病菌的傳染性質。

(六) 護理措施

1. 根據被感染的細菌種類確認為血液傳播的模式。
2. 適當的分配病人的床位及隔離預防措施，照會感染管制人員。
3. 遵守血液、體液感之染防護措施。
4. 教導病人家屬傳播過程之注意事項。

(七) 衛教指導

1. 病人以及接觸者之指導

- (1) 梅毒為法定通報傳染病，確診病人應呈報當地衛生主管機關，絕對尊重個人隱私。
- (2) 隔離：血液、體液和分泌物均有傳染性，故其處理要特別小心。
- (3) 消毒：病人未經治療，其分泌物及污染物品應接受消毒，但已接受適當處理及治療之病人則已不具感染性。
- (4) 定期追蹤檢查：嬰兒應在 3、6、12 月大重覆非梅毒螺旋體抗原試驗 VDRL。
- (5) 先天性梅毒家庭成員已確認之早期梅毒病人，因有傳染性所以他們的性接觸者均需接受治療。

2. 預防方法：

- (1) 健康之全面性提昇，衛生教育與性教育之推廣。把梅毒血清檢查列為性病科門診及產前檢查之例行篩檢項目。如孕婦有可疑之高危險因素，更應在懷孕前期及後期各驗血 1 次，甚至臨產時之血清篩檢，俾能有效預防先天性梅毒之發生。
- (2) 有效防止及控制娼妓、特種營業人員、以及與其有性接觸的人所發生之性傳染病；避免多重之性活動，推廣正確之個人預防方法，例如正確使用保

主題名稱	先天性梅毒	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N02	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	4/6

險套，不與配偶以外的人發生性關係，不胡亂使用藥物。

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(一) 謝武勳、吳美環、陳倩儀(2014)・先天性感染，實用新生兒科醫療手冊（二版，234-238 頁）・台北：台大。

(二) 陳月枝、黃靜微、林元淑、張綠怡、蔡綠蓉、林美華...魏琦芳(2021)・實用兒科護理學（9 版）・台北市：華杏。

七、附件

(略)

主題名稱	先天性梅毒	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N02	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	5/6

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
97.05.31	1.0	新制定	97 年 05 月 31 日 護理部照護標準 委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
100.08.31	2.1	修改常見治療內容	100 年 08 月 31 日 護理部照護標準 委員會通過
101.08.31	2.2	醫護部改護理部	101 年 08 月 31 日 護理部照護標準 委員會通過
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.08.31	3.1	增修第六項參考文獻資料	104 年 08 月 31 日 護理部照護標準 委員會通過
105.08.31	3.2	將參考文獻出處呈現於內文中	105 年 08 月 31 日 護理部照護標準 委員會通過
106.08.31	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.04.02	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.09.23	3.3	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第五目刪除文字：傳播。 3. 第三項第八目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 11 日 護理長會議通 過；108 年 09 月 23 日督導會議通 過公布。
109.08.18	3.4	第三項第六、七目說明內容文字修訂。	109 年 08 月 06 日 照護標準組會議 通過；109 年 08 月 12 日護理長會 議通過；109 年 08 月 18 日督導會議

